

TEMA 5.17 • OFTALMOLOGÍA

misceláneos 2

PERFIL EUNACOM 6.02.1.020
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Misceláneos de Oftalmología Frecuentes en APS

1. Pingüecula y Pterigión

Ambas son proliferaciones anormales de tejido fibrovascular, altamente motivadas y exacerbadas por la prolongada **Exposición Solar Crónica (Rayos UV)** y ambientes con polución o polvo continuo (factor de riesgo fundamental en trabajadores agrícolas y labores a la intemperie).

TABLA 5.17.1: DIFERENCIAS CLAVE VS PINGÜECULA		
DIFERENCIAS CLAVE	PINGÜECULA	PTERIGIÓN ("CARNOSIDAD")
Topografía Anatómica	Crecimiento estacionado exclusivo en la Conjuntiva Bulbar pura. (A ambos lados del iris pero no lo roza).	Excrecencia agresiva invasiva; Traspasa la conjuntiva, monta el limbo e Invade francamente el tejido de la Córnea de forma triangular.
Afectación Visual	Es un hallazgo benigno estético. No entorpece ni afecta absolutamente nunca el campo ni la agudeza óptica.	Puede causar tracción causando Astigmatismo de base e inducir ceguera focal si el ápice obstructivo avanza y llega a tapar mecánicamente el eje visual de la pupila central.
Tratamiento General	1. Lubricación básica (Lágrimas Artificiales). 2. Educación y Fotoprotección (Lentes de Sol envolventes con filtro UV estricto, factor N°1 de manejo).	Igual manejo conservador al inicio. Criterios de cirugía: Cuando empieza a arruinar eje visual, astigmatismo agresivo o gran componente estético. (Nota: Posee alta tasa de recurrencia).

2. Leucocoria vs Leucoma

Corresponden a dos hallazgos per se, con el ojo blanco central, pero de significados topográficos y bases etiológicas diferentes:

- **Leucocoria (Pupila Blanca):** Fisiopatología retro-corneal puramente que opacifica las biópticas e impide el rojo reflejo pupilar.
- - **Adultos Edad Avanzada:** Lejos, la causa primordial a diagnosticar in situ clínica son las severas **Cataratas maduras blancas corticales**. Suelen derivar a cirugía profiláctica y de recuperación de luz vitalicia.
- - **Niños y Pediátricos (Banderas Rojas Vitales):** Primer gran diagnóstico obligatorio: Catarata Congénita (ambliopizante severa urgente a operar). Segundo imperativo de descarte letal masivo y de altísimo riesgo maligno es un mortífero **Retinoblastoma** de base neuroectodérmico o también la Retinopatía isquizante del Prematuro ROP.
- **Leucoma (Córnea Blanca Cicatricial):** Es una lesión directa por **Opacidad fibrosa o Cicatriz superficial francamente en estroma y córnea exterior**. Resulta en la evolución fibrótica remanente de una reparación post inflamatoria tras fuertes o negligudas grandes úlceras o Queratitis profundas destructivas agudas de arrastre crónicos de larga data que requirió tejido fibrosante desestructurado macizo perimetral. En estadios ciegos terminales macizos sólo admiten **Trasplantes de Córneas queratoplásticos**.

3. Xantelasmas

- **Clínica Superficial Directa:** Aparición lenta de típicas placas o manchas levantadas discretamente, planas abultables de textura y pigmento crasamente **Amarillento o color mantequilla rutilante bilobulado**. Localizados clásicamente en el canto interno subcutáneo de los párpados superior e inferonasal. - **Asociación y Manejo Sistémico de Urgencias Silentes:** Al ser descubiertos en inspección general su presencia cutánea no daña el ojo per sé, pero sirve de poderoso factor dermatológico marcador sistémico del EUNACOM apuntando fuertemente a una base metabólica latente grave oculta del paciente, requiriendo su obligado sondeo de sospecha frente a base de **Dislipidemias / Hipertrigliceridemias e Hipercolesterolemias Familiares severas subyacentes letales**. Imponiendo requerir de base inmediata y control perimetral mediante tamizaje con un general completo del **Perfil Lipídico generalizado**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una mujer de cuarenta y dos años con diagnóstico de enfermedad de Graves de dos años evolución consulta por protrusión ocular bilateral progresiva y diplopía al mirar hacia arriba. Los anticuerpos anti-receptor de TSH están elevados. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo inicial más adecuado para un caso activo con inflamación?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para misceláneos 2. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La orbitopatía tiroidea es la causa más frecuente de proptosis bilateral en adultos y es casi exclusiva de la enfermedad de Graves.
- El mecanismo involucra anticuerpos anti-receptor de TSH y anti-IGF-uno que estimulan fibroblastos orbitarios produciendo engrosamiento muscular y proptosis.
- El tratamiento de la orbitopatía tiroidea se escala según severidad: observación, corticoides, biológicos como teprotumumab o tocilizumab, radioterapia o cirugía descompresiva.
- El pseudotumor orbitario es inflamación orbitaria idiopática con manejo similar a la orbitopatía tiroidea activa.
- Los tumores palpebrales y conjuntivales son análogos a los tumores de la piel: carcinoma basocelular, espinocelular y melanoma, todos requieren biopsia.
- El retinoblastoma en niños se manifiesta como leucocoria y tiene excelente pronóstico si se diagnostica precozmente, con sobrevida superior al noventa y cinco por ciento.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MISCELÁNEOS 2)

PREGUNTA 1

Una mujer de cuarenta y dos años con diagnóstico de enfermedad de Graves de dos años evolución consulta por protrusión ocular bilateral progresiva y diplopía al mirar hacia arriba. Los anticuerpos anti-receptor de TSH están elevados. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo inicial más adecuado para un caso activo con inflamación?

- A) Pseudotumor orbitario bilateral; tratamiento con radioterapia inmediata
- B) Celulitis orbitaria bilateral; tratamiento con antibióticos intravenosos
- C) Orbitopatía tiroidea activa; tratamiento con corticoides sistémicos
- D) Linfoma orbitario bilateral; biopsia urgente
- E) Orbitopatía tiroidea leve; observación sin tratamiento

PREGUNTA 2

Respecto a los tumores palpebrales y conjuntivales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) Son tumores exclusivos de la órbita que no tienen análogos en la piel
- B) Los tipos más frecuentes son carcinoma basocelular, espinocelular y melanoma, análogos a los de la piel
- C) Son siempre benignos y no requieren biopsia
- D) El retinoblastoma es el tumor palpebral más frecuente en adultos
- E) Se tratan siempre con radioterapia sin necesidad de biopsia previa

PREGUNTA 3

¿Cuál es la causa más frecuente de proptosis bilateral en adultos y cuál es su mecanismo fisiopatológico principal?

- A) Pseudotumor orbitario bilateral; mecanismo idiopático inflamatorio
- B) Orbitopatía tiroidea; anticuerpos anti-receptor de TSH y anti-IGF-uno que estimulan fibroblastos orbitarios
- C) Celulitis orbitaria bilateral; mecanismo infeccioso bacteriano
- D) Linfoma orbitario bilateral; infiltración linfocítica del tejido orbitario
- E) Metástasis orbitarias bilaterales; infiltración tumoral del tejido orbitario

RESUMEN: MISCELÁNEOS 2

Esta clase aborda tres temas misceláneos de oftalmología: la orbitopatía tiroidea, el pseudotumor orbitario y los tumores oculares y anejos. La orbitopatía tiroidea, también llamada oftalmopatía de Graves, es la causa más frecuente de proptosis bilateral en adultos. Es característica casi exclusiva de la enfermedad de Graves, aunque puede aparecer con otras tiroidopatías. El mecanismo involucra anticuerpos anti-receptor de TSH y anti-receptor de IGF-uno que estimulan los fibroblastos de la órbita, produciendo proliferación del tejido orbitario con engrosamiento de los músculos extraoculares y proptosis progresiva. Clínicamente puede producir proptosis con o sin diplopía según si los músculos extraoculares están comprometidos. El diagnóstico se confirma con anticuerpos anti-receptor de TSH. El manejo es observación en casos leves; corticoides sistémicos en casos activos con inflamación; fármacos biológicos como teprotumumab, tocilizumab o rituximab en casos más agresivos; y radioterapia orbitaria o cirugía descompresiva en casos severos. El pseudotumor orbitario o inflamación orbitaria idiopática es una inflamación orbitaria sin causa identificable que tiene un manejo similar a la orbitopatía tiroidea. Los tumores intraoculares y de anejos incluyen el retinoblastoma en niños, que se presenta como leucocoria, y los tumores conjuntivales y palpebrales, que son análogos a los tumores de la piel: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma, todos los cuales requieren biopsia y tratamiento específico.